

Profil biochimique et marqueurs biologiques du cancer du pancréas dans l'Est algérien

I. Hamiouda^{1*}, R. Laouar¹, Y. Khenchoul², K. Sifi³, D. Satta¹

¹ Département de Biologie Animale, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université des Frères Mentouri Constantine 1, Laboratoire de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Algérie.

² Service de Chirurgie Générale A, Centre Hospitalo-Universitaire Constantine 3, Algérie.

³ Laboratoire de Biologie et de Génétique Moléculaire, Université Constantine 3, Algérie.

Email : imenhamiouda@gmail.com

INTRODUCTION

- ▶ Cancer du pancréas (CP) : tumeur très létale.
- ▶ Diagnostic souvent tardif → pronostic défavorable.
- ▶ En Algérie (2022) :
 - 1 168 nouveaux cas
 - 1 136 décès.
- ▶ **CA19-9** : biomarqueur principal mais spécificité limitée.
- ▶ Peu de données dans l'Est algérien.

PATIENTS & MÉTHODES

TYPE D'ÉTUDE

- ▶ Cas-témoins rétrospectif.
- ▶ CHU Constantine.
- ▶ 10 ans (2013-2023).

POPULATION

- ▶ 188 cas (CP confirmé).
- ▶ 227 témoins.
- ▶ Ratio 1:1,2.
- ▶ Appariés : âge + commune.

PARAMÈTRES BIOLOGIQUES

- ▶ ASAT / ALAT.
- ▶ Phosphatases alcalines (PAL).
- ▶ Bilirubine totale.
- ▶ Glycémie.
- ▶ CA19-9.

ANALYSE STATISTIQUE

- ▶ t-test / Mann-Whitney U.
- ▶ χ^2 de Pearson.
- ▶ Régression logistique (univariée + multivariée).
- ▶ Seuil : $p < 0,05$.

ÉTHIQUE

- ▶ Déclaration d'Helsinki.
- ▶ Approbation institutionnelle.
- ▶ Consentement éclairé.

RÉSULTATS (profil)

PROFIL DES PARTICIPANTS

N = 415
 Cas : 188
 Témoins : 227
 Ratio : 1 : 1,2

Âge moyen : $63,6 \pm 11,3$ ans
 Pic : 60-69 ans (36,7 %)
 Hommes : 54,8 %

CARACTÉRISTIQUES TUMORALES

Siège
 Tête du pancréas : 84,0 %
 Corps/Queue : 16,0 %

Type histologique
 Adénocarcinome : 83,3 %
 Autres : 16,7 %

Stade TNM
 M1 (métastases) : 33,9 %
 M0 : 66,1 %

Signes cliniques
 Ictère : 67,0 %
 Douleur abdominale : 76,7 %

PROFIL BIOCHIMIQUE

Paramètre	Témoins	Cas	p
ASAT (U/L)	17,9	88,0	<0,001
ALAT (U/L)	12,7	85,0	<0,001
PAL (U/L)	100,4	385,0	<0,001
Bilirubine ($\mu\text{mol/L}$)	7,2	89,3	<0,001
Glycémie (g/L)	1,0	1,6	0,002
CA19-9 (U/mL)	22,7	257,4	<0,001

Tous les paramètres sont significativement élevés chez les patients CP.

CHOLESTASE SÉVÈRE

Bilirubine $\times 12$ - PAL $\times 3,8$ - Transaminases $\times 5$

RÉSULTATS (facteurs)

FACTEURS ASSOCIÉS

Régression logistique multivariée (ajustée)

Facteur	AOR	IC95%	p
Diabète	2,32	1,52-3,53	<0,001
Obésité	0,28	0,16-0,50	0,001
Tabagisme	1,18	0,71-1,96	NS
HTA	0,92	0,56-1,52	NS

AOR : Odds Ratio ajusté ; NS : non significatif

DISCUSSION

CHOLESTASE

- ▶ Reflet des tumeurs céphaliques (84 %).
- ▶ Signe d'alarme devant ictère du sujet âgé.

CA19-9

- ▶ Élévation majeure ($\times 11$).
- ▶ Utile en complément de l'imagerie.
- ▶ Non spécifique (cholestases bénignes).

DIABÈTE

- ▶ AOR = 2,32.
- ▶ Deux mécanismes possibles :
 - Facteur de risque préexistant.
 - Conséquence tumorale (destruction des îlots).
- ▶ Distinction impossible (rétrospectif).

OBÉSITÉ PARADOXALE

- ▶ Effet protecteur apparent (AOR = 0,28).
- ▶ Hypothèses :
 - Biais de cachexie (IMC sous-estimé).
 - Biais de sélection.
 - Différences ethniques.

LIMITES

- ▶ Design rétrospectif.
- ▶ Données issues des dossiers.
- ▶ Absence de durée du diabète.
- ▶ Monocentrique.
- ▶ IMC mesuré au diagnostic (pas antérieur).

CONCLUSION

CE QU'IL FAUT RETENIR

CHIFFRES-CLÉS

Bilirubine $\times 12$
CA19-9 $\times 11$
Diabète $\times 2,3$
 (AOR = 2,32)

- ✓ Profil de cholestase obstructive sévère.
- ✓ Diabète = facteur de risque majeur.

MESSAGE CLINIQUE

Devant tout :

- ▶ Ictère
- ▶ Douleur abdominale
- ▶ Sujet > 60 ans

Réaliser :

- ▶ Bilan hépatique
- ▶ Glycémie
- ▶ CA19-9

Diabétique = cible de surveillance rapprochée.

PERSPECTIVES

- ▶ Études prospectives.
- ▶ Cohorte multicentrique.
- ▶ IMC avant diagnostic.
- ▶ Distinguer diabète :
 - Préexistant.
 - Paraneoplasique.
- ▶ Facteurs génétiques spécifiques à l'Algérie.

RÉFÉRENCES ESSENTIELLES

- Bray F. et al., 2024. Global cancer statistics 2024. *GLOBOCAN*.
- Mizrahi J. D. et al., 2020. Pancreatic cancer. *Lancet*.
- Ballehaninna U. K., Chamberlain R. S., 2012. CA19-9 as a biomarker for pancreatic cancer. *J Gastrointest Oncol*.
- Goonetilleke K. S., Siriwardena A. K., 2007. CA19-9 and cholestasis in pancreatic and biliary disease. *Eur J Surg Oncol*.
- Ben Q. et al., 2011. Diabetes and pancreatic cancer risk: a meta-analysis. *Diabetes Care*.